

Síntesis de evidencia: DBT en adolescentes

Panorama general de los principales estudios controlados

Resumen orientativo de los hallazgos más citados sobre DBT adaptado a adolescentes. Se recomienda revisar las fuentes originales para el detalle metodológico completo.

Estudio / línea de investigación	Población	Hallazgo principal
Ensayo controlado de Oslo (Mehlum y cols.)	Adolescentes con autolesiones repetidas y rasgos límite.	DBT superior a tratamiento habitual mejorado en reducir autolesiones e ideación suicida.
Estudio piloto de Nueva Zelanda (Cooney y cols.)	Adolescentes con intento de suicidio o autolesión reciente.	El formato DBT resultó viable de implementar y bien tolerado por adolescentes y familias.
Estudio con trastorno bipolar (Goldstein y cols.)	Adolescentes suicidas con diagnóstico de trastorno bipolar.	Mayor reducción de síntomas depresivos y de desregulación emocional en el grupo DBT.
Estudios cuasi experimentales (Rathus & Miller y otros)	Adolescentes multiproblemáticos, con conducta suicida o autolesiva.	Resultados prometedores en reducción de conductas de riesgo, con seguimiento sostenido en el tiempo.

CLAVE CLÍNICA

La mayoría de la evidencia proviene de población con conducta suicida/autolesiva activa o rasgos límite; la generalización a otras poblaciones adolescentes debe hacerse con cautela.